



表 19 ECMO 治疗启动参数设置与初始管理表(2)

一、患者信息与模式选择					
姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	__岁	体重	__kg (PBW __kg)	床号	__床
模式	☐ VA ☐ VV ☐ VAV ☐ ECPR	插管方式	☐ 股股 ☐ 股腋 ☐ 颈股 ☐ 其他__	上机时间	__:__
三、ECMO 管路初始参数					
3.1 模式参数对照表					
参数	VA-ECMO 推荐值	VV-ECMO 推荐值	说明		
初始血流量	1.5-2.0L/min	500 mL→逐步升至 2.0 L/min	初始低流量→稳定后渐增		
初始转速	1500-2000RPM	1500-2000RPM	视管路阻力、静脉引流调整		
目标血流量	50-70mL/kg/min	60-80mL/kg/min	VV 需更高流量满足氧合; VA 需平衡左心后负荷		
初始 FiO ₂	1.0(100%) →渐降至 0.5-0.6	1.0(100%) →渐降至 0.6-1.0	稳定后据血气下调		
扫气流量 (Sweep)	初始 2L/min,按 PaCO ₂ 调节	初始 2 L/min, 按 PaCO ₂ 调节	扫气↑=CO ₂ 清除↑; VV 模式下尤为重要		
气:血比	初始 1:1	初始 1:1~2:1	血流稳定后按需调整		
3.2 实际设置记录					
参数	VA-ECMO 实际值	VV-ECMO 实际值	ECPR 实际值		
穿刺时间	__:__	__:__	__:__		
转流时间	__:__	__:__	__:__		
初始血流量	__ L/min	__ L/min	__ L/min		
初始转速	__ RPM	__ RPM	__ RPM		
目标血流量	__ L/min	__ L/min	__ L/min		
FiO ₂ 设定	__ %	__ %	__ %		
扫气流量	__ L/min	__ L/min	__ L/min		
四、抗凝方案初始设定					
项目	选项/设定值		说明		
抗凝药物	☐ 普通肝素 ☐ 阿加曲班 ☐ 无抗凝		肝素为首选; HIT 患者选阿加曲班		
预冲液是否加肝素	☐ 不加 ☐ 加 (剂量__ U)		多数中心不加血栓风险者可加 2500-5000 U		
首次肝素给药时机	☐ 穿刺开始时 ☐ 导丝进入时 ☐ 转流前		导丝进入后即刻给药 (推荐), 防止插管血栓		
肝素首剂 (负荷量)	__ U (成人常用 5000 U / 50-100 U/kg)				
肝素维持剂量	__ U/kg/h (初始常用 10-20 U/kg/h)		根据首剂后 15-30 min ACT/APTT 调整		
4.1 抗凝监测目标					
监测指标	无活动性出血	有活动性出血	当前值		
ACT	160-200 s	130-160 s	__ s		
APTT	50-80 s	40-50 s	__ s		
抗 Xa (如有)	0.3-0.5 IU/mL	0.2-0.3 IU/mL	__ IU/mL		
监测频率	q1-2h ACT / q6h APTT (初期)	同上	—		

依据: ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + ELSO VA-ECMO 过渡指南 (2021) + ELSO 抗凝指南 (2021) + EOLIA 2018 + CESAR 2009 + 肺保护通气策略

用途: ECMO 上机即刻填写, 指导开机 0-24h 的参数设置和目标管理

提示: 低流量运行时抗凝需维持高限; 高流量、活动性出血或胸腔引流增多时可维持低限。